

Logística Hospitalar

EDMUNDO SOUZA



Unidade 2

Livro Didático
Digital



Diretor Executivo
DAVID LIRA STEPHEN BARROS

Diretora Editorial
ANDRÉA CÉSAR PEDROSA

Projeto Gráfico
MANUELA CÉSAR ARRUDA

Autor
EDMUNDO SOUZA

Desenvolvedor
CAIO BENTO GOMES DOS SANTOS

O AUTOR

Edmundo Souza

Olá. Meu nome é Prof. Edmundo Souza. Sou formada em Administração Hospitalar, com uma experiência técnico-profissional na área de Gestão Administrativa, Compras e Suprimentos, mais de 25 anos. Passei por empresas como a Amil, Hospital São Camilo, Grupo Hemocentro São Lucas, Hospital e Maternidade Voluntários. Como professor de cursos superiores e pós-graduação, mais de 12 anos. Passei por empresas como Anhanguera Educacional, FMU, Laureate International Universities e SENAC. Atualmente trabalho no Departamento de Compras e Suprimentos do GNDI-Grupo NotreDame Intermédica e também sou Tutor EAD da UNIP. Sou apaixonado pelo que faço e adoro transmitir minha experiência de vida àqueles que estão iniciando em suas profissões. Por isso fui convidada pela Editora Telesapiens a integrar seu elenco de autores independentes. Estou muito feliz em poder ajudar você nesta fase de muito estudo e trabalho. Conte comigo!

ICONOGRÁFICOS

Olá. Meu nome é Manuela César de Arruda. Sou a responsável pelo projeto gráfico de seu material. Esses ícones irão aparecer em sua trilha de aprendizagem toda vez que:



INTRODUÇÃO:
para o início do desenvolvimento de uma nova competência;



NOTA:
quando forem necessários observações ou complementações para o seu conhecimento;



EXPLICANDO MELHOR:
algo precisa ser melhor explicado ou detalhado;



SAIBA MAIS:
textos, referências bibliográficas e links para aprofundamento do seu conhecimento;



ACESSE:
se for preciso acessar um ou mais sites para fazer download, assistir vídeos, ler textos, ouvir podcast;



ATIVIDADES:
quando alguma atividade de autoaprendizagem for aplicada;



DEFINIÇÃO:
houver necessidade de se apresentar um novo conceito;



IMPORTANTE:
as observações escritas tiveram que ser priorizadas para você;



VOCÊ SABIA?
curiosidades e indagações lúdicas sobre o tema em estudo, se forem necessárias;



REFLITA:
se houver a necessidade de chamar a atenção sobre algo a ser refletido ou discutido sobre;



RESUMINDO:
quando for preciso se fazer um resumo acumulativo das últimas abordagens;



TESTANDO:
quando o desenvolvimento de uma competência for concluído e questões forem explicadas;

SUMÁRIO

Os princípios básicos da gestão hospitalar	11
Administração Hospitalar	13
Controle.....	22
O que se gerencia em um hospital.....	25
Hospitalidade	26
Hospitalidade: Desafios.....	29
Logística hospitalar.....	33
Planejamento Estratégico.....	35
Compras.....	36
Estoque.....	37
Curva ABC.....	38
Distribuição Interna.....	40
O papel da tecnologia na logística hospitalar.....	43

UNIDADE

02

INTRODUÇÃO

Sabemos que o principal objetivo de uma organização de saúde é oferecer um atendimento eficiente aos pacientes. Entretanto, uma logística e gestão incorretas podem impedir que esse objetivo seja alcançado.

O processo de logística hospitalar é uma teia, ou seja, para que o objetivo seja alcançado, a gestão e a logística devem funcionar em conjunto. Isso traz um impacto positivo para o equilíbrio financeiro da instituição e para a segurança à saúde dos pacientes.

Com as novas tendências tecnológicas na saúde, tudo tende a ser realizado de maneira mais tranquila, através da automatização. Um software ou as ferramentas de gestão tendem a trazer mais segurança que significam mais vantagens para a instituição

Além disso, é bom ressaltar a importância de investir numa equipe de gestão capacitada e bem treinada. Não adianta possuir os melhores e mais modernos softwares se os profissionais não estão preparados para utilizá-los.. Entendeu? Ao longo desta unidade letiva você vai mergulhar neste universo!

OBJETIVOS

Olá. Seja muito bem-vindo à **Unidade 2**. Nosso objetivo é auxiliar você no desenvolvimento das seguintes competências profissionais até o término desta etapa de estudos:

- 1.** Conhecer os princípios básicos da Gestão Hospitalar.
- 2.** Compreender as estruturas e funções administrativas da Gestão Hospitalar.
- 3.** Compreender a gestão da cadeia de suprimentos no âmbito hospitalar.
- 4.** Identificar, analisar e compreender a estrutura da logística hospitalar.

Então? Preparado para uma viagem sem volta rumo ao conhecimento? Ao trabalho!

Os princípios básicos da Gestão Hospitalar



OBJETIVOS

Ao término deste capítulo você será capaz de entender como funciona a gestão hospitalar e os princípios pelos quais ela ocorre. O profissional que trabalha com gestão hospitalar, necessita de conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias para o melhor desempenho da função. Isto será fundamental para o exercício de sua profissão. E então? Motivado para desenvolver esta competência? Então vamos lá. Avante!

Figura 1: Gestor Hospitalar



Fonte: Freepik

A logística hospitalar e sua cadeia de suprimentos tem como referencial a base de atuação da logística empresarial. A ideia central da gestão de logística hospitalar é garantir o produto correto, no momento

certo, para o paciente indicado. Produtos englobam os materiais específicos da área da saúde; os insumos, medicamentos, equipamentos, móveis, utensílios específicos, peças elétricas, eletrônicas e materiais comuns como produtos de limpeza, escritório e outros. A logística oferece os recursos materiais, requisito de entradas nos setores para transformação de serviços.

A logística de suprimento é representada pelo departamento de compras. Este, recebe as solicitações de compras dos setores: Almoxarifado, Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF), Serviço de Nutrição e Dietética (SND) e Departamento de Gestão de Projetos (DGP). Existem hospitais que os setores da CAF e SND realizam suas compras diretas com a cadeia de suprimentos, não passando pelo setor de compras. Em muitos hospitais estes dois setores são terceirizados por empresas especializadas. Deste modo espera-se maior eficácia destes serviços, além da redução de custos para o hospital.

A Logística de suprimentos trata da relação com toda a cadeia de suprimentos externa da saúde. Esta cadeia é composta por representantes, fornecedores e fabricantes de insumos para a saúde, tais como: laboratórios, farmácias, empresas de produtos de saúde, empresas de móveis para hospitais, equipamentos hospitalares, produtos de segurança em saúde, empresas de tecnologia de informação, de engenharia, marcenaria, arquitetura e outros.

A Logística de suprimentos trata dos processos da compra: o que comprar, quando comprar, de quem comprar? Tendo como processos de trabalho o cadastramento dos fornecedores, contratos, cotação, fechamento da compra, avaliação dos fornecedores sendo submetidos às regras e normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária- ANVISA que regula a produção e comercialização de produtos para saúde e do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - INMETRO, setor que atesta confiabilidade aos equipamentos destinados à saúde.

A logística interna cuida do fluxo interno do controle e distribuição do material nas dependências do hospital: O almoxarifado é o setor responsável pelo correto recebimento dos materiais, correto armazenamento, controle de estoque, e sua movimentação, distribuição para:

Unidades assistenciais: CTI, Centro Cirúrgico, Pronto Socorro, Unidades de Internação, Hemodinâmica e outros;

Unidades de apoio: Lavanderia, Rouparia, Hotelaria, Manutenção Predial, Manutenção Biomédica, Conservação e Limpeza, Tecnologia de Informação, SESMT, e outros;

Setores Administrativos: Diretoria, Departamento de Gestão de Projetos, Financeiro, Contabilidade, Jurídico, Recursos Humanos e outros.

Há nos hospitais a logística reversa específica; A Central de Material Esterilizado (CME) área de apoio logístico responsável pelo reprocessamento e reutilização de materiais instrumentais e outros, utilizados durante o tratamento do paciente, sendo o bem durável. Recolhe o material, reprocessa por diferentes mecanismos da esterilização, embala, estoca e distribui pelos setores assistenciais.

Setor de responsabilidade técnica e legal do profissional Enfermeiro que também segue normas e portarias da ANVISA.

O setor de compras e almoxarifado hospitalar precisa ser gerenciado por profissionais qualificados. Os processos de trabalho destes setores requerem conhecimentos, habilidades e atitudes pertinentes à formação acadêmica da área da administração e gestão hospitalar.

Administração Hospitalar

As funções administrativas são interrelacionadas, sendo que o resultado de cada uma das áreas tem influência direta no resultado final da organização. Por esse motivo é importante conhecê-las e estudá-las.

Definem-se como funções administrativas o planejamento, organização, comando, controle e coordenação. De forma abreviada, é possível dizer que as funções administrativas são representadas pela sigla POC3.

Planejamento

O planejamento é uma atividade sistêmica que visa, deforma organizada, prever os recursos necessários para serem utilizados no momento certo e da maneira correta, para atingir resultados desejados.

O planejamento responde a questões básicas, como:

- O que fazer?
- Para que fazer?
- Como fazer?
- Com quais recursos fazer?
- Quando fazer?
- Com quem fazer?

Em outras palavras, consiste em: determinar objetivos, formular estratégias, políticas e planos e a partir daí tomar decisões. O planejamento tem por finalidade permitir trabalharem deforma integrada as diversas áreas da organização para atingirem um mesmo objetivo, sempre observando o que ocorre dentro e fora dela. Cinco são as atividades básicas do planejamento:

- avaliação das condições atuais;
- tempo;
- problemas de previsão;
- coleta e análise de dados; e
- coordenação de planos.

Objetivos

O que são objetivos?

Os objetivos refletem um conjunto de desejos a serem atingidos. Os desejos que compõem os objetivos podem ser denominados de metas.

Uma organização pode ter um ou mais objetivos. Em geral, podemos traçar um objetivo principal, que pode ser decomposto por objetivos menores, ou seja, objetivos específicos. Muitas vezes, a causa da falha de uma organização pode estar na falta de objetivos e metas bem determinados.

O que são metas?

Metas são desejos que têm como características o fato de se-rem específicas, realistas, com possibilidades de verificação, deter-minação de prazos para a sua realização e a existência de alvos para serem atingidos. Em um hospital podemos observar tanto metas pessoais como organizacionais:

- as metas pessoais são aquelas que refletem os desejos das pessoas que lá trabalham. Ex: desejo de ser promovido em um ano para o cargo de supervisor; e
- as metas organizacionais são aquelas que refletem os desejos da organização – no nosso caso o hospital. Ex: aumentar o número de leitos em 20% no próximo ano. Os objetivos servem também como fatores de motivação individual. Quando sabemos para onde ir, buscamos pensar em formas para lá chegar. Então, podemos dizer que os objetivos servem de guias para as nossas ações.



SAIBA MAIS

Existem teorias que afirmam que as pessoas somente agem de determinadas formas quando os objetivos do grupo afetam seus objetivos e interesses pessoais. Ou seja: se os objetivos de uma organização afetam os interesses pessoais, a probabilidade de que as pessoas se comportem de forma favorável é maior. Portanto, quanto maior for a participação dos membros da organização na formulação de planos e objetivos, maior a chance de alcançarem o resultado desejado. A contribuição de todos é um elemento decisivo!

Importância do ambiente no planejamento

O ambiente externo não é constante e exige que frequentemente sejam realizadas análises sobre aspectos demográficos, tecnológicos, econômicos, políticos, culturais e ambientais. Toda variação que possa, de alguma forma, influenciar nos resultados da organização deve ser levada em conta. No ambiente interno, a estrutura organizacional deve ser favorável ao processo de planejar, de forma a ser flexível e adaptável às contingências necessárias.

Organização e estruturação



DEFINIÇÃO

A organização é vista como elemento fundamental para que os objetivos sejam alcançados, conforme o esperado. A organização enquanto processo de gestão, possibilita o uso racional de recursos para o alcance de objetivos, de maneira eficiente e eficaz.

No processo produtivo, inclusive no segmento de serviços, a organização tem como objetivo fundamental convergir o resultado gerado pelos recursos disponíveis. Os principais tópicos para que isso aconteça estão na divisão do trabalho e na delegação de responsabilidades e de autoridade.

Divisão do trabalho

A divisão do trabalho tem como primeiro resultado a departamentalização, a qual pode ocorrer segundo:

- **convergência em função da área territorial de ação.** Ex: um hospital pode ter diferentes seções conforme a área de atuação. No caso, matriz na capital do Estado e regionais ou filiais em cidades menores;
- **convergência em função dos clientes.** Ex: num mesmo hospital podem ser oferecidos serviços que são privados,

para conveniados, e/ou direcionados para o público em geral. Combinações de algumas das modalidades anteriores. Ex: atendimento ambulatorial, exames anatomopatológicos, testes laboratoriais, análises clínicas, hospital-dia;

- **convergência em função de um produto ou serviço.** Ex: em um hospital podemos dividir a estrutura por serviços prestados, como UTI (Unidade de Terapia Intensiva), maternidade, oncologia, entre outros;
- **natureza das atividades desempenhadas.** Ex: departamento financeiro, administrativo, serviços gerais, comercial, dentre outros, de acordo com o porte e o grau de especialização produtiva da entidade em análise; e
- **convergência em função de um processo produtivo.** Ex: ministrar soro (prescrição médica), gotejamento digitalizado (setor de informatização) e monitoramento (equipe de enfermagem).

Hierarquia

A estrutura hierárquica pode ser apresentada de forma horizontal ou vertical:

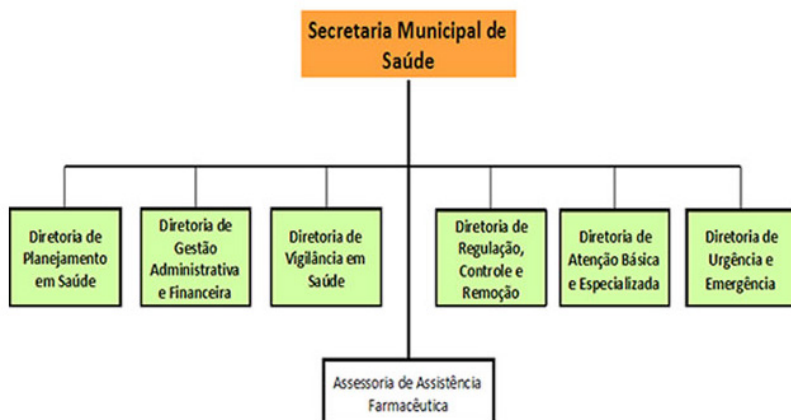
A estrutura vertical envolve elementos fundamentais, que são:

- posições que consistem de tarefas, responsabilidades e autoridades proporcionais;
- políticas de saúde, planos, objetivos, procedimentos em todos os níveis; e
- papéis, status e autoridades dos indivíduos que exercem os cargos. Organizações mais simples envolvem hierarquias mais simples e compactas. Organizações maiores tendem a apresentar estruturas maiores e, em alguns casos, menos enxutas. A criação de departamentos, dentro de um hospital, é resultado da tentativa de organizar as atividades

lá existentes. A estrutura organizacional geralmente pode ser apresentada por meio de organogramas. Por intermédio deles podemos visualizar as estruturas de cargos e subordinações existentes.

Vamos observar um exemplo de organograma:

Figura 2: Organograma do Ministério da Saúde definindo cargos e funções



Fonte: O autor (2020)

Comando ou Liderança

O comando, enquanto função, exige características do gestor, seja na aplicação de recursos (ex: dinheiro, material administrativo e pessoal) ou no relacionamento com as pessoas e entidades que estão relacionadas à organização (ex: pacientes, funcionários, enfermeiros, médicos e fornecedores).

Tappan (1976, p. 167) destaca que: “Por causa das situações críticas que surgem com tanta frequência num hospital todos os serviços têm necessidade de chefes enérgicos capazes de tomar decisões precisas, mas que ao mesmo tempo sejam bem educados”.

A boa liderança, baseada na educação e empatia, é essencial para o bom funcionamento do hospital.

O comando envolve a delegação de responsabilidades e o desenvolvimento dos interesses nas pessoas para que os objetivos desejados se realizem. Para isso é necessário que exista a habilidade de liderar e fazer com que as pessoas se esforcem, sintam-se motivadas a realizar o que se espera.

Existem três vertentes nas abordagens de comando:



Fonte: Freepik (Layout)

A terceira forma de comando tem sido a que, atualmente, vem mostrando melhores resultados. Quando as pessoas sentem-se parte de um conjunto e com o direito de participação, a tendência para que os resultados aconteçam é maior.



REFLITA

A função de comando envolve então a busca por fazer com que as pessoas assumam, de fato, a responsabilidade por ações para o alcance de objetivos, direta ou indiretamente. A função de comando envolve então a busca por fazer com que as pessoas assumam, de fato, a responsabilidade por ações para o alcance de objetivos, direta ou indiretamente.

Coordenação

Uma organização para atingir os objetivos desejados precisa trabalhar de forma conjunta. O trabalho em conjunto, de forma eficiente e eficaz, é denominado coordenação

Figura 3 – Equipe coordenadora



Fonte: Freepik

O fracasso na coordenação pode ser decorrente de uma série de fatores, tais como: perda de controle, conflito excessivo, divisão de autoridade e competências e responsabilidades ignoradas.

Podemos dizer que para alcançar uma boa coordenação é necessário que tenhamos bem definidos os seguintes aspectos:

- hierarquia de autoridade;
- mecanismos de coordenação entre departamentos;
- pessoal;
- centralização;

- descentralização das atribuições;
- delegação de tarefas e responsabilidades; e
- poder e influência.

A hierarquia determina fatores como a "cadeia" ou estrutura de comando, unidade de comando e a amplitude (tamanho) de controle. A coordenação interdepartamental responde a questões, tais como:

- Onde precisamos de coordenação?
- Qual o grau de necessidade?
- Quais os mecanismos que podem facilitar a coordenação?
- Quais os mecanismos adequados para cada situação? Os mecanismos mais comuns de coordenação são:
- planos e regras; reuniões programadas, de improviso (emergência) e de avaliação;
- responsabilidades de coordenação de departamentos; e
- uso de intermediários.

A escolha do pessoal, na atividade de coordenação, responde à seguinte questão: Quem será a pessoa adequada para resolver a necessidade?

Para tanto, devemos fazer uma análise do problema da nossa organização e relacioná-la com as competências e habilidades necessárias para que o profissional a ser escolhido exerça tal atividade.

No momento em que tomamos tais decisões, estamos analisando a capacidade de outras pessoas atuarem de forma adequada para atingir os objetivos que desejamos.

Quando centralizamos o poder partimos do princípio de que não temos em nossa organização pessoal capaz de assumir a responsabilidade por determinada ação ou resultado que desejamos.

Podemos dizer então que: A decisão de centralizar envolve a combinação entre autoridade, informação e competência.

A delegação de autoridades, tarefas e responsabilidades significa a passagem destas para um subordinado. Para que isso aconteça é necessária uma delimitação da abrangência da delegação, clareza e suficiência ou necessidade.

Então aquele que tem a capacidade de mudar o comportamento de outra ou de outras pessoas tem poder. O mesmo não acontece, necessariamente, com quem tem autoridade (título/cargo).

Controle

Para mantermos o rumo desejado precisamos saber como e para onde ir. O controle é justamente o intermediário entre esses dois pontos, ou seja, é a forma de nos certificarmos que estamos no caminho certo.

A função de controle engloba três elementos principais:

- estabelecimento de padrões de desempenho;
- medição de desempenho; e
- comparação entre o desempenho obtido e o esperado.

O controle deve ser constante para que o que desejamos aconteça exatamente da forma que esperamos.

Quando realizamos o controle e verificamos que o desempenho obtido apresenta desvios em relação ao esperado, um quarto elemento deve entrar em ação: o uso de medidas corretivas.

Podemos utilizar uma série de instrumentos para controle: agendas, cadernos, programas de computador, quadros e murais, avaliações periódicas, entre outros. Tudo depende da nossa necessidade e da infraestrutura que possuímos.

O controle também pode ser feito tanto de forma qualitativa como quantitativa:

- Controle qualitativo: pode ser feito por meio de observações do ambiente, conversas e entrevistas com as pessoas envolvidas com o objeto de controle.
- Controle quantitativo: pode ser realizado através de comparações entre os desempenhos traçados no planejamento e os resultados obtidos.

Conhecer as funções de um gestor ou superior direto é o primeiro passo para conhecer sua própria atividade! Quanto maior o grau de conhecimento em gestão, maior chance de contribuição, por parte dos funcionários, para que se alcancem os objetivos traçados pela organização se realizem. É possível notar nos hospitais e organizações que o gestor do futuro é, cada vez mais, uma pessoa que apresenta habilidades e competências para trabalhar de forma autônoma.

Contabilidade

A contabilidade é uma atividade diretamente relacionada à função de controle. O controle das contas pode ser realizado por áreas funcionais, se for esse o caso, a divisão estrutural mais simplificada pode ser categorizada em:

- administrativa;
- operações;
- manutenção da propriedade;
- marketing; e
- energia.

Sendo o controle, realizado pela contabilidade, visualizam-se as estruturas de receitas e gastos e, conseqüentemente, possíveis gastos

excessivos. A controladoria tem a tarefa de verificar todas as contas de movimentação do hospital, assim como de desenvolver as atividades que envolvem planejamento, execução, controle e análise de desempenho da gestão. O responsável pela contabilidade pode ser denominado de controller (controlador). Vamos então conhecer o seu trabalho. O controller, nome dado ao profissional da área, atende à crescente necessidade de controles eficientes do capital investido, de análises da carga tributária incidente nos negócios e dos riscos conjunturais, além de observar as tendências e perspectivas do mercado, considerando a produtividade e os custos, trabalho que busca oferecer informações confiáveis para a tomada de decisões.

Mais uma função da controladoria é assessorar outros departamentos da organização por meio das conclusões de análises de seus relatórios e de estudos que recomendam e orientam quanto à execução de processos que salvaguardem os objetivos corporativos de lucratividade. A controladoria também participa, por meio de monitoramento, da implementação e da validação de diretrizes da organização, como por exemplo, um plano de ação. Com trânsito em um ambiente de tantos dados, planilhas, relatórios complexos e rigorosos, o controller, profissional atento à lógica do negócio e zeloso da racionalidade dos processos de trabalho, pode ir muito além da burocracia e do controle. Da posição de observador privilegiado que desfruta, a qual envolve mais que números e índices, e com sua visão ampla e generalista, o controller deve ter a sensibilidade voltada não somente para os resultados de funcionamento, mas também para a percepção do quanto as pessoas são afetadas pelas atividades que desempenham. (HAYES, 2005, p. 133)

O que se gerencia em um hospital

Conforme Asenjo (2002), o hospital tem como finalidade gerir:

- a saúde das pessoas, que inclui o nascimento e a morte;
- interrelações pessoais. Pessoas que estão doentes, ou sesentem doentes são ajudadas por outras saudáveis, ou quese sentem saudáveis. Esse conceito caracteriza o hospitalcomo instituição máxima de interrelação social;
- os interesses de quatro amplos e poderosos grupos: cida-dãos doentes ou não, profissionais da saúde (em geralcom nível de escolaridade avançado), gestores e administradores e proprietários (sejam privados ou públicos);
- a necessidade de objetivação de tais interesses; e
- um grande grupo de pessoas trabalhando em função daqueles que são atendidos e ou hospitalizados, em enorme número de pessoas assistidas e seus familiares e acompanhantes; sendo, portanto, um local de máxima interação social.



SAIBA MAIS

O administrador ou gestor hospitalar atua como a base do hospital. É ele quem estabelece e decide as linhas de ação da organização. Trata-se de um coordenador geral que lida com as diversas dimensões para garantir o funcionamento contínuo e adequado. Dessa forma, é ele o responsável direto perante o conselho.

As funções principais do administrador hospitalar podem serresumidas em:

- implantar uma organização adequada;

- unir os líderes;
- coordenar as atividades;
- tomar decisões;
- rever as linhas de ação existentes;
- organizar as bases;
- planejar, persuadir e gerenciar; e
- delegar tarefas.

Hospitalidade

A noção de hospitalidade vem da expressão latina *hospitalitas*, e tem como significado: o ato de acolher, hospedar; a qualidade do hospiteiro; boa acolhida; recepção; tratamento afável, cortês, amabilidade; gentileza. (DIAS, 2002).

Analisando diversos conceitos de hospitalidade, podemos descrever tal ato como o bom acolhimento dispensado ao hóspede através do fornecimento de hospedagem, alimento e entretenimento, quando este está fora de casa, de forma a lhe proporcionar o bem-estar.

Figura 4: hospitalidade



Fonte: Freepik

A hospitalidade é um fenômeno amplo, que não está restrito à oferta de abrigo e alimento ao visitante, mas ao ato de acolher nas suas diversas perspectivas. Tal ato envolve um conjunto de estruturas, serviços e atitudes que, intrinsecamente relacionados, proporcionam o bem-estar ao hóspede. (DA CRUZ, 2002).

Destaca-se inclusive que o ato de ser hospitaleiro reflete na união de indivíduos de forma a não haver a exclusão.

Trata-se de uma ação que se insere na ideia de qualidade de vida. Grinover (2002) destaca que atos relacionados à hospitalidade devem ser considerados como a consolidação de estruturas de relações ou como relações transformadoras. A hospitalidade tem tamanha influência nas relações humanas, ao ponto de transformar estranhos em amigos e pessoas próximas - tenhamos como exemplo a relação dos profissionais da saúde quando em contato com os familiares do paciente, ou do próprio paciente com o médico que lhe atende.

Morcef de Paula (2002) destaca que, do ponto de vista tradicional de marketing, a hospitalidade é vista como exclusiva da atividade hoteleira e de serviços de alimentação que satisfaçam a demanda por acomodação, alimento e bebida fora de casa. Do ponto de vista atual trazemos tal conceito para a atividade hospitalar. A hospitalidade pode ser estendida para além da atividade hoteleira, situando-se também na atividade hospitalar. O próprio conceito de hospital já tem suas raízes na hospitalidade. A palavra hospital deriva - também do latim - de hospitaleicum, com o significado de hospedaria ou casa de hóspedes. (DIAS, 2002).

O hospital que trata bem os seus pacientes (clientes) tem como premissas recebê-los bem, fornecer boas acomodações, alimento de qualidade e mantê-los entretidos durante a sua estadia, tudo isso visando o seu bem-estar.

O hospital que recebe e trata bem seu paciente aumenta as chances de ser bem-sucedido, seja no tratamento médico e cura, seja na formação de atitudes favoráveis em relação à sua imagem. A hospitalidade é influenciada não só pelas relações humanas, mas também pelo espaço onde elas ocorrem.

Goudbout (apud GRINOVER, 2002) crê que a hospitalidade é um dom do espaço, espaço da habitação, espaço para percorrer a pé ou para contemplação, sendo suas qualidades a superfície, a acessibilidade, o conforto, a estética e a historicidade. O local hospitalar é um local de doação, de proteção e segurança, além de ser um abrigo (hospedagem) e fornecer a alimentação.

O local hospitalar tem a sua avaliação, por parte daquele que é recebido, influenciada por fatores como odor, hábitos, costumes, história e memória. A formação da imagem em relação ao local varia conforme o visitante. "No processo de percepção e re-cepção, o visitante é ativo, pois seleciona, de acordo com seus próprios critérios de significação, os elementos que devem compor a imagem". (GRINOVER, 2002, p. 35).

Da Cruz (2002) acredita que a origem da hospitalidade é fundamentada em aspectos sócio-culturais, profissionais, políticos e espaciais:

- Aspecto sócio-cultural: sustenta-se na ideia de que indivíduos ou grupos apresentam a predisposição de acolher um visitante, sendo esse um ato social e culturalmente construído, seja de forma voluntária ou não. No caso dos hospitais não só deve ser voluntária como constante.
- Aspecto profissional: na hospitalidade, refere-se à necessidade de ter pessoal preparado, treinado e de ser uma atividade planejada. A hospitalidade em atividades profissionais – e aí situa-se o caso dos hospitais – refere-se aos serviços criados para atender hóspedes (pacientes ou não) de forma a lhes proporcionar bem-estar.
- Aspecto político: baseia-se na criação de uma hospitalidade que envolva iniciativas institucionalizadas. As políticas podem envolver aspectos desde a criação de ambientes acolhedores, como práticas de trabalho que favoreçam a criação de tais ambientes.

A dimensão espacial envolve o desenvolvimento de espaços propícios à hospitalidade.

Criam-se e aperfeiçoam-se ambientes agradáveis para aqueles que utilizam o espaço hospitalar e hospitaleiro.

O que diferencia a experiência – elemento de importância já destacada – entre um e outro paciente, no que se refere à hospitalidade, é a forma como se dá o seu acolhimento no hospital. O ambiente onde se desenvolvem as relações de hospitalidade tem a mesma importância para atrair e promover a satisfação do cliente. Por isso destaca-se a importância de observar os aspectos indiretos que não representam o produto principal (o tratamento), mas que colaboram para a sua avaliação, como a cordialidade do serviço, o conforto do ambiente e a qualidade, dentre outros fatores. (DE PAULA, 2002).

Vejamos o exemplo do alimento: o alimento com sua cor, textura e aroma remete o indivíduo às mais remotas lembranças de experiências positivas ou negativas vivenciadas em determinadas situações. (DE PAULA, 2002) A avaliação do mesmo é de caráter subjetivo e varia conforme o indivíduo. Daí a famosa expressão "co-mida de hospital". Se não existe o trato na elaboração e entrega da comida oferecida ao paciente, a lembrança não será favorável.

A hospitalidade, destaca a autora, está associada a questões além da hospedagem e alimentação.

O exercício da hospitalidade e gestão hospitaleira (e conseqüentemente hospitalar) envolve aspectos relacionados direta e indiretamente com seu desenvolvimento, que exigem: planejamento e organização de recursos materiais, humanos, naturais e/ou financeiros.

Hospitalidade: Desafios

Na área de serviços, em especial, a aplicação do conceito da hospitalidade não é uma tarefa simples. Para iniciar, ao contrário de relações individualistas podemos fazer uso de palavras e gestos que conduzam a relações plurais.

Agregar o conceito de hospitalidade torna a tarefa de administração hospitalar ainda mais complexa, contudo mais prazerosa. Pois, em

paralelo, na evolução do setor (de serviços) tem crescido a preocupação e a necessidade de se retomar as bases da convivência humana como uma espécie de retaliação ao caos vivenciado na sociedade contemporânea. (DA CRUZ, 2002).

A hospitalidade pode resgatar as regras de boa convivência, cordialidade, bem-estar e a qualidade de vida.

Quanto a casos que podem ser relacionados a esse contexto vistos e vivenciados no cotidiano dos hospitais? Vamos conhecer as principais mudanças nas características dos hospitais que influenciam diretamente na “gestão hospitalar hospitalar”.

Observe o Quadro 1:

Quadro 1: Mudanças das características do hospital

Hospital atual	Hospital do futuro
Necessidades profissionais	Necessidades da população
Curar doenças	Criar estilos de vida saudáveis
Ambiente frio	Ambiente caloroso
Cada hospital com todos os serviços	Centros especializados
Funcionalmente ineficaz	Centros operativos
Paciente com serviços básicos	Pacientes com conforto
Indiferença ante o hóspede	Sensibilidade frente ao hóspede
Paciente interno	Paciente externo
Cirurgia invasiva	Cirurgia não invasiva
Público pouco informado	Consumidor exigente
“Não se pode passar...”	“Passe, não vai ser perdido...”
Obsoleto em cinco anos	Pensando para ser flexível e mutante
Imagem genérica	Estratégia
Hospital tradicional	Centro ou campo de serviços de saúde

Fonte: Asenjo (2002, p. 113)

Em face do aperfeiçoamento de estruturas hospitalares, seja na dimensão tecnológica ou na disponibilidade de capital humano, ocorre o desenvolvimento de atividades turísticas. Ou seja, as pessoas se deslocam para tratar de saúde e usufruem de equipamentos de lazer e entretenimento.

De acordo com o Quadro 1 é necessário conscientizar-se que o trabalho e a gestão hospitalar devem se organizar de acordo com as exigências dos clientes e do mercado em geral, ou seja, da sociedade!

Uma das exigências vem sendo refletida na prática do turismo de saúde – especialmente destacado pela medicina alternativa que responde aos aspectos não contemplados pela medicina contemporânea.

O turismo de saúde é realizado especialmente em instituições privadas, que muitas vezes estão próximas das melhores disponibilizadas pela própria estrutura turística – ou seja, hospitais que oferecem infraestrutura de nível similar a dos melhores hotéis para pacientes e familiares. Tanto clínicas de repouso para idosos, como spas e centros de terapia medicinal estão inclusos nessa categoria.

Vejamos o caso dos hospitais alternativos, como são os spas e os centros de

termalismo. Seu desenvolvimento ocorre, principalmente, porque as pessoas passam a buscar alternativas tanto para o tratamento de cura como de prevenção aos males da saúde. Assim, esses estabelecimentos respondem ao questionamento da busca por estilos de vida mais naturais, por alimentação mais saudável e menos tóxica, considerando as questões ambientais. O tratamento alternativo para dificuldades psicofísicas motiva o paciente não só a buscar novas formas para alcançar os mesmos resultados, como também motiva a prática de uma modalidade de turismo diferenciada: o turismo de saúde.

O turismo de saúde é, portanto, "... o conjunto de atividades turísticas que as pessoas realizam na procura de meios de manutenção ou de aquisição do bom funcionamento e da sanidade do seu físico e do seu psiquismo". (SILVA, 1994, p. 20) Ou seja, as pessoas viajam para tratar a saúde para realizar

check-ups, dietas especiais, tratamentos com complexos vitamínicos, tratamentos com ervas, hidroterapia, homeopatia e acupuntura, dentre tantas alternativas.

O perfil do turista em busca da saúde pode variar desde o jovem que busca sanar questões estáticas (ex: obesidade) até o adulto (ex: stress) ou idoso (ex: questões relacionadas à idade). O praticante do turismo de saúde tem como característica o senso crítico. Devido ao fato de ele realizar o tratamento e pagar por livre e espontânea vontade, o seu potencial de divulgação dos serviços, seja positiva ou negativamente, é elevado. O seu retorno depende da qualidade do serviço que lhe será prestado – seja em pequenas temporadas ou curtas permanências. Para explorar esse nicho são necessários não somente investimentos nas instalações hospitalares, como também desenvolvimento de acessos rodoviários, infraestrutura hoteleira, postos de serviços, atrações turísticas, eventos, beleza natural e hospitalidade. Silva (1994) destaca que, mesmo diante do fato de as fontes de águas minerais (como exemplo) serem um valioso diferencial mercadológico, não há, em grande parte das estâncias brasileiras, estrutura sólida para o seu aproveitamento terapêutico ou turístico.

Logística hospitalar

Para Neil (2004; p.14); logística e suprimentos hospitalares, quando bem geridos tornam-se apoio estrategicamente eficaz quando estão unidos com recursos humanos e administração comercial. Para que haja um impacto positivo na assistência e no desenvolvimento de atividades em atenção à saúde, tais fatores necessitam de total atenção e acompanhamento.

Reconhecer que há falhas no sistema de abastecimento, seja ele público ou privado, e que as justificativas pela "falta de material" muitas vezes não são aprofundadas, ainda amenizam os fortes impactos negativos que tais medidas podem trazer tanto à instituição, enfraquecendo sua imagem, como também aos profissionais, à comunidade e principalmente ao paciente, que é o maior prejudicado. Lambert (2000) questiona sobre a importância dessa discussão e pelos problemas que a má gestão pode gerar dentro das instituições e por estar alheio à literatura nacional.

Faz-se necessário um estudo apurado e minucioso das causas que ocasionam tais disfunções no processo de abastecimento e desabastecimento. Os motivos e ou justificativas podem variar e revelar outros fatores como desperdícios, má utilização de insumos e instrumentos como equipamentos. Neste sentido é possível questionar também sobre o nível de qualificação e de conhecimento técnico exigido em algumas áreas, dos colaboradores que atuam nos setores de armazenagem e de distribuição. Por meio dessa averiguação buscar desenvolver medidas que possibilitem mitigar tal situação. Uma medida possível é o replanejamento logístico dentro das organizações de saúde.

A complexidade de uma instituição de saúde é alta. Além de ter um funcionamento ativo de 365 dias por ano e de 24 horas por dia, ainda possui uma extensa organização interna distribuída por sistemas e por subsistemas. O setor de armazenagem e distribuição funciona como um subsistema que "alimenta", por meio da reposição de insumos para consumo, outros sistemas que trabalham em uma cadeia contínua de produção e que dependem diretamente do bom gerenciamento

e de ações bem definidas para que a execução das atividades dos profissionais de saúde que estão diretamente na assistência ao enfermo e também àqueles que estão indiretamente ligados a eles, por exemplo no setor administrativo, possam ser eficazmente realizadas, pois cada departamento depende de um tipo específico de insumo.



Fonte: Freepik

E por tratar de insumos que são utilizados em instituições de saúde, a responsabilidade, mesmo antes do processo de produção e de aquisição, deve ser ainda maior, por isso a boa qualificação dos profissionais é de extrema importância. Vecina e Reinhardt (2002) estimam que o arsenal de insumos de um hospital apresente uma média entre 3.000 a 6.000 componentes frequentemente adquiridos, de acordo com o tipo das atividades desempenhadas pela instituição. Fazem parte deste arsenal os materiais de consumo médico-hospitalares, medicamentos e reagentes para testes diagnósticos, além de materiais especiais, como órteses e próteses (OPME's), e também itens de escritório, limpeza e alimentos.

Pesquisas aprofundam o tema relacionado à economia potencial e a melhora na qualidade da assistência, consequências da racionalização

do sistema de armazenagem, reiterando a importância de implementar os conceitos de logística e cadeia de suprimentos para organizar o sistema de execução e de produção do hospital.

Lambert (2000) traz o conceito de que cadeia de suprimentos deve realçar a integração ativa, interna e externa dos participantes de todas as etapas – “criadores” do produto, fornecedores de insumos, responsáveis pela logística de aquisição, armazenamento e distribuição dos insumos e responsáveis pela fabricação e distribuição final do produto, incluindo o próprio cliente final. E se isso não está acontecendo dentro da instituição, há grandes chances de ocorrerem intercorrências.

Planejamento Estratégico

A definição de planejamento estratégico partilhada por Borba (2006) se resume à maneira de pensar e repensar “de uma organização” (Borba, 2006), focalizando seu futuro e avaliando criticamente o ambiente externo. Ele também conceitua o planejamento estratégico como sendo um: “[...] processo que realmente mobiliza as pessoas e a organização para construir o seu futuro”. (Borba, 2006).

Para que o planejamento estratégico aconteça, alguns critérios devem ser estabelecidos, a começar com a inclusão participativa de quatro componentes que possuem especial poder no que tange à discussão e agrupamento de informações, sabendo utilizá-las como suportes à tomada de decisão. Destacam-se fornecedores, concorrentes, clientes e a própria organização. Para iniciar o planejamento estratégico é imprescindível a participação desses componentes, para que assim as formulações dos objetivos da instituição sejam concretizadas. É perceptível que muitas organizações ou estabelecimentos de saúde, aos poucos, estão introduzindo, em seu escopo de atuação, o seu mapa de valores com objetivos claros e estrategicamente alinhados com sua missão, visão e valores.

Compras

O departamento de compras é responsável pelo processo de aquisição de insumos que são utilizados na organização. A organização de pessoal e suas respectivas responsabilidades podem ter pequenas diferenças entre um hospital ou outro, mas o padrão de sua principal função deve considerar o relacionamento com fornecedores, negociação de preços, prazos de entregas e planejamento de compras programadas com vistas à redução de custos (Dias, 1995).

Para que as compras ocorram de forma eficaz financeiramente, é imprescindível que outros setores ligados diretamente ao setor de compras sejam integrados por meio da comunicação direta com as atividades do estoque satélite. Isto porque há uma programação de compras pré-estabelecida e a determinação das quantidades é influenciada pelas informações de demanda e estoques de segurança, que são originadas no setor de estoque (Ballou, 1993)

Quando não há programação de compras ou quando há situações não previstas, são realizadas compras emergenciais, neste sentido as compras tidas como de urgência, e tendo como consequências, muitas vezes, o aumento de custos, etapas de negociação abortadas e força de barganha mínimas, favorecendo ao fornecedor.

Sempre que possível, situações como essas precisam ser evitadas, pois significam perdas para a instituição.

Sob a perspectiva hospitalar, Paterno (1990), salienta que Compras é o ofício de maior importância dentro da logística de um hospital e pode ser definida como "uma ocupação que tem por finalidade antever os materiais necessários ao hospital, planejar as quantidades corretas e satisfazê-las no momento certo, na melhor qualidade e ao menor custo". Castelar, Mordelet e Grabois (1995) ratificam sobre a relevância do setor de compras em atender às solicitações de suprimentos, que englobam armazenagem e distribuição, farmácia e nutrição, dentro das condições e prazos exigidos, decorrendo a adequada seleção/definição de fornecedores que ofereçam os melhores preços, condições de pagamentos e produtos com qualidade.

O tipo de compra utilizado pode variar entre duas classificações, conforme o grupo de material comprado, incluindo ou não o frete no preço. São eles:

- CIF (Cost Insurance Freight) – Custo, seguro e frete – onde o fornecedor responsabiliza-se pelo frete, competindo a este fornecer uma guia para que o comprador possa resgatar o produto. Quem arca com o custo é o próprio fornecedor.
- FOB (Free On Board) o fornecedor responsabiliza-se por meio de contrato pela mercadoria até a hora em que ela é entregue, na data e hora, ao correio escolhido pelo comprador. Este valor não contempla o orçamento do fornecedor, caberá ao comprador calculá-lo de acordo com o serviço de frete que indicou.

Estoque

Para Dias, (1995), estoque tem a finalidade de suprir de insumos e de maneira quase imediata a demanda requisitada pelos setores chaves da instituição. Garante que mesmo em meio às oscilações o atendimento seja realizado.

Genericamente, para que haja o ressuprimento adequado e imprescindível à produção ou à prestação de serviços, o setor de armazenagem precisa planejar e monitorar as quantidades mínimas necessárias a fim de corroborar para que não aconteça faltas, principalmente quando for requisitado (Ballou, 1993).

Ballou, após pesquisa, apresenta alguns métodos que têm por objetivo assessorar o planejamento de estoques. Tais ferramentas foram originadas a princípio na engenharia de produção, mas também foram e são adaptadas a outras atividades e serviços. São técnicas matemáticas e estatísticas parametrizadas segundo os métodos de pesquisa operacional e de sistema integrados à tecnologia da informação, que varia de acordo com cada organização hospitalar. Os resultados são a garantia

da disponibilidade dos materiais requisitados, considerando o custo de armazenagem, critérios de ressuprimento e consequências causadas pela falta de materiais à medida que são requisitados (Ballou, 1993).



Fonte: Freepik

Curva ABC

Os parâmetros apresentados abaixo não são uma regra rígida, pois podem variar de organização para organização nos percentuais descritos. O que importa é que a análise destes parâmetros propicia o trabalho de controle de estoque.

A decisão de compra pode basear-se nos resultados obtidos pela curva ABC. Os itens considerados de Classe A merecerão um tratamento preferencial. Assim, a consequência da utilidade desta técnica é a otimização da aplicação dos recursos financeiros ou materiais, evitando desperdícios ou aquisições indevidas e favorecendo o aumento da lucratividade.

Segundo Carvalho, (2002) os itens são classificados como de:

- De Classe A: de maior importância, valor ou quantidade, correspondendo à 20% do total (podem ser itens do estoque com uma demanda de 70% num dado período);
- De Classe B: com importância, quantidade ou valor intermediário, correspondendo a 30% do total (podem ser itens do estoque com uma demanda de 15% num dado período);
- De Classe C: de menor importância, valor ou quantidade, correspondendo a 50% do total (podem ser itens do estoque com uma demanda de 5% num dado período).

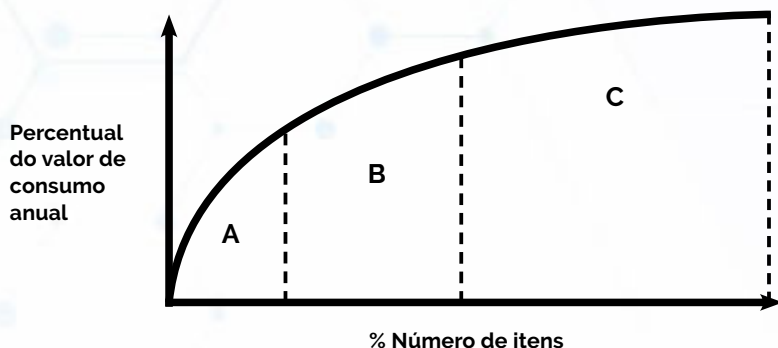
Os conceitos e a classificação da curva ABC explorados também por Carvalho (2002), revelam que a Curva ABC tornou-se ao longo dos anos uma ferramenta útil nos mais diversos setores em que se necessita tomar decisões envolvendo grande volume de dados e a ação torna-se urgente, muito utilizada para avaliação de estoques, produção, vendas, salários e outros.

A Curva ABC é um método de classificação estatística de materiais, baseada no princípio de Pareto, em que se considera a importância dos materiais, baseada nas quantidades utilizadas e no seu valor. (Carvalho, 2002).

Também pode ser utilizada para classificar clientes em relação aos seus volumes de compras ou em relação à lucratividade proporcionada; classificação de produtos da empresa pela lucratividade proporcionada, etc.

Numa organização, a Curva ABC é muito utilizada para a administração de estoques, mas também para definição de políticas de vendas, para o estabelecimento de prioridades, para a programação de produção, etc. Para a administração de estoques, por exemplo, o administrador a usa como um parâmetro que informa sobre a necessidade de aquisição de itens – mercadorias ou matérias-primas – essenciais para o controle do estoque, que variam de acordo com a demanda do consumidor, interno ou externo. A Figura abaixo mostra um exemplo

de Curva ABC, aplicado ao Valor de Consumo Anual correlacionado ao Número de Itens em Estoque.



Distribuição Interna

A atividade de distribuição de materiais que acontece dentro da organização faz referência à dinâmica da movimentação de insumos entre estoques ou do estoque maior para os sub-estoques distribuídos em setores estratégicos, à prestação de serviço e de atendimento e aos pontos de produção de insumos quando estes exigem algum preparo anterior à entrega, por exemplo, nas farmácias, quando há a necessidade de manipulação de medicamentos oncológicos que, dependendo de sua composição e forma de administração, o especialista, (normalmente um farmacêutico), precisa prepará-lo e deixá-lo pronto para consumo. Os critérios essenciais para que haja uma melhor distribuição consideram o roteamento da movimentação e racionalização de recursos (Ballou, 1993).

É papel da distribuição garantir que materiais e medicamentos requisitados cheguem ao local de destino no momento, na quantidade e na especificação corretos.

Todas as intercorrências advindas pela falta de planejamento podem acarretar atrasos, perda de credibilidade e insegurança diante, por exemplo, de algum procedimento médico. Outra consequência acarretada pela falta de planejamento é a perda de controle e daí as perdas financeiras à organização (Daniel, 1997). Castelar, Mordelet e

Grabois (1995) ponderam que o processo de distribuição é um dos pontos que geram mais conflitos na cadeia de suprimentos hospitalares.

Para Castelar, Mordelet e Grabois (1995) e Paterno (1990), é aceitável ter como parâmetro padrão possíveis modelos de distribuição e que são utilizados na administração de materiais de vários hospitais. São eles:

- Distribuição coletiva ou sistema de complementação da previsão – os materiais e medicamentos são expedidos a subestoques nas enfermarias e unidades de internação. Todos os dias são realizadas as requisições para repor os materiais utilizados no dia anterior e no caso de medicamentos, a requisição é feita de acordo com a prescrição médica. O benefício desta metodologia é a redução do trabalho da farmácia. A maior desvantagem é o risco de perda de controle por parte da farmácia de armazenagem e permitir que o controle dos materiais seja assumido pela enfermagem, ocasionando risco de desvio, deterioração e prazos de validade vencidos, maior possibilidade de falhas na medicação ocasionada pelo distanciamento do farmacêutico e do corpo clínico (prescrições médicas).
- Distribuição semi-coletiva ou sistema de unidades móveis – nesta metodologia a entrega de medicamentos é realizada por meio de requisições ou prescrições médicas diariamente. A vantagem é a diminuição do estoque de medicamentos dentro dos subestoques, maior segurança devido à presença do farmacêutico conferindo sempre as prescrições médicas e menor risco de falhas na medicação. A desvantagem é o excesso de atividade por parte dos auxiliares e técnicos de farmácia e a consequência podendo gerar atrasos no recebimento do medicamento.
- Sistema de distribuição de medicamentos por dose-unitária ou sistema da ordem de produção – neste método os medicamentos são acondicionados em doses unitárias ou individualizadas para cada paciente, mediante a segunda via da prescrição médica. Este processo é mais complexo

e exige uma participação maior dos farmacêuticos e também maior investimento no que diz respeito à compra de embalagens e de etiquetas para identificação das doses unitárias. Mas os resultados compensam, pois, as vantagens são percebidas pela redução de manipulação por parte da enfermagem, redução de erros na dispensação e administração dos medicamentos e possibilidade de o farmacêutico verificar e controlar todas as prescrições.

Castelar, Mordelet e Grabois (1995) ponderam e fazem algumas observações e dizem que algumas publicações ratificam reduções de gastos com medicamentos e correlatos da ordem de 20% a 30 % após a implementação deste método.

O papel da tecnologia na logística hospitalar

Para que aconteça uma administração eficaz na cadeia de suprimentos, é de real importância correlacionar informações e transformá-las em ferramentas estratégicas no processo decisório. Para Fleury, Wanke e Figueiredo (2000, p.286): "Pedidos de clientes e de ressuprimento de necessidades de estoque, movimentações nos armazéns, documentação de transporte e faturas são alguns dos exemplos mais comuns de informações logísticas". E para que essas informações sejam otimizadas e melhor garimpadas, faz-se necessário recorrer à tecnologia da informação, trazendo efeitos positivos e ganhos consideráveis e eficientes de controle, acompanhamento e suporte às decisões.

Todas as ferramentas apresentadas pelos sistemas de informações integradas possibilitam aos gestores e outros interessados munirem-se de informações, por exemplo, sobre o status de pedidos dos clientes, determinações de políticas de controle de estoques, controle da movimentação interna de materiais, comunicação eficiente com fornecedores e distribuidores etc.

Paterno (1990) pontua as seguintes finalidades da utilização da TI nos procedimentos logísticos de um hospital: preparar previsões de consumo, assessorar no planejamento, controlar informações referentes a fornecedores, controlar dados sobre compras (quando e quanto comprar), calcular consumo médio mensal, calcular o estoque de segurança, prever rotatividade de inventário, (cíclico ou anual), destacar erros de previsão, controlar a localização de materiais e medicamentos, controlar os subestoques, fornecer relatórios que apoiem a tomada de decisões, (principalmente os relatórios de ressuprimento) e indicadores operacionais.



Fonte: Freepik



RESUMINDO

E então? Gostou do que lhe mostramos? Aprendeu mesmo tudinho? Agora, só para termos certeza de que você realmente entendeu o tema de estudo deste capítulo, vamos resumir tudo o que vimos. Você deve ter aprendido sobre os princípios básicos da gestão hospitalar, a administração hospitalar, planejamento e questões básicas, como é composta a gerencia de um hospital e as funções principais do administrador hospitalar. Assim como o conjunto de procedimentos de gestão, planejados e implementados a partir de bases científicas e técnicas, normativas e legais, com o objetivo de garantir a rastreabilidade, qualidade, eficácia, efetividade, segurança e em alguns casos o desempenho das tecnologias de saúde utilizadas na prestação de serviços de saúde.

Abrange cada etapa do gerenciamento, desde o planejamento e entrada no estabelecimento de saúde até seu descarte, visando à proteção dos colaboradores, a preservação da saúde do meio ambiente e a segurança do cliente (paciente).

REFERÊNCIAS

COBRA, Marcos. Estratégia de marketing em serviços. São Paulo: Cobra, 2001. DA CRUZ, R. de C. A. Hospitalidade Turística e Fenômeno Urbano no Brasil: considerações gerais. In MORAES DIAS, Célia Maria de (Org.).

Hospitalidade: reflexões e perspectivas. São Paulo: Manole, 2002. DE PAULA, N. M. de. Introdução ao Conceito de Hospitalidade em Serviços de Alimentação. In MORAES DIAS, Célia Maria de (Org.).

Hospitalidade: reflexões e perspectivas. São Paulo: Manole, 2002. DIAS, C. M. de M. O Modelo de Hospitalidade do Hotel Paris Ritz: um enfoque especial sobre a qualidade. In MORAES DIAS, Célia Maria de (Org.).

Hospitalidade: reflexões e perspectivas. São Paulo: Manole, 2002. FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda.

Novo Dicionário Eletrônico Aurélio. Versão 5.0. 3. ed. by Regis Ltda, 2004. GRINOVER, Lucio. Hospitalidade: um tema a ser reestudado e pesquisado. In MORAES DIAS, Célia Maria de (Org.).

Hospitalidade: reflexões e perspectivas. São Paulo: Manole, 2002. HAMPTON, David R. Administração Contemporânea : teoria, prática e casos. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 1992. HAYES, David K.

Gestão de Operações Hoteleiras / David K. Hayes e Jack D. Ninemeier. Tradução de Vivian Fittipaldi e Beth Honorato. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2005.

Logística Hospitalar

Edmundo Souza



TeleSapiens